EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 74084
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2023-11-14 12:58:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CLAUDINA DEL CARMEN OLAVE CONTRERAS			RUN	: 6.153.837-2
F.Nac	: 07-11-2023	Edad	: 0 AÑO	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-11-08	Fecha Egreso	: 2023-11-14 12:58:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. E10.5-DIABETES MELLITUS INSULINODENDIENTE CON COMPL. CIRC. PERIFER

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Shock séptico foco cutáneo resuelto.
1.1 Amputación supracondilea derecha
1.2 Pie diabético complicado
2. LRA KDIGO 3 no oligurica resuelta
3. Antecedentes: DM2, HTA, ACV secuelada, Postrada

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. R57.2-CHOQUE SEPTICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. E10-DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de HTA, DM2, postrada, ACV secuelada. Ingresa a SU HSC el día 07.11.23 por UPP talón derecho con mala evolución, evaluada por cirujano y se decide realizar amputación supracondilea derecha que se concreta el mismo día. Dentro de exámenes de ingreso destaca crea 4.6, uremia 257, GB 22600, segmentados 87%, PCR 77. Paciente sale de pabellón con compromiso hemodinámico, con requerimientos de DVA a dosis bajas, además cursa con LRA KDIGO 3 no oligurica. Se evalúa a paciente en URA en regulares condiciones generales, no cooperadora, con compromiso hemodinámico, por lo que se decide ingreso a unidad para manejo y monitorización. Se inicia tratamiento antibiotico con Ceftriaxona + Metronidazol, manejo del dolor con BIC de analgesia, Hidratación vigilada. Se logra mejoria de LRA, actualmente resuelta. Hemodinamicamente con buena evolución, se logra destete de NAD. Alimentandose por SNG, recupera vigilia, reevaluada por Fonoaudiologa, se indica mantener SNG + alimentación via oral. Actualmente con hemodinamia autosostenida, sin conflicto ventilatorio, parametros inflamatorios a la baja con doble cobertura antibiotica, funcion renal recuperada. Evaluado por Cirujano, se realiza traslape antibiotico oral para completar 14 dias. Se decide HODOM para manejo de curaciones, KNT y educación de uso de SNG.

PLAN DE MANEJO:

HODOM: Curación c/48 hrs, Knt Motora, Educación de uso SNG.
Control en CAE Cirugia en 2 semanas.

INDICACIONES AL ALTA

1. HODOM: Curación c/48 hrs, Knt Motora, Educación de uso SNG.
2. Regimen por SNG , Glucerna 250 cc x 4 veces + Regimen papilla
3. Amoxicilina/Acido Clavulánico (875/125) 1 comprimido c/12 hrs por 7 dias SNG

4. Paracetamol 500 mg c/ 8hrs por 5 dias SNG
5. Omeprazol 20 mg por la mañana SNG
6. Atorvastatina 40 mg 1 comprimido por la noche SNG
7. Memantina 10 mg 1 comprimido al día SNG
8. Pregabalina 75mg 1 comprimido por noche SNG
9. Insulina NPH 6 UI am - 6 UI pm sc
10. Losartan 50 mg 1 comprimido c/12 hrs SNG
11. Digoxina 0.25 MG 1/2 comprimido LU - VI SNG
12. Control en CAE Cirugia en 2 semanas.

EXÁMENES Y RESULTADOS

13/11/23: Crea 0.2, PCR 40, Uremia 100, ELP 141/3.5/114, Blancos 13900, Hb9.6, Hto 29.5%, Plaquetas 314000

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

DANIELA VASQUEZ BAHAMONDEZ
MEDICO TRATANTE
16516335-4

JEFE SERVICIO